Kurzbericht zur Beratung
Christian BRAND, geb. 27.05.1978

1. Beratungsauftrag

Der 46jährige Polizeihauptkommissar (PHK) stellte sich Ende Februar 2025 aufgrund eines Rezidivs seiner depressiven Erkrankung vor. Nach dem Tod seiner Mutter im Oktober 2024 habe er eine zunehmende Stimmungsverschlechterung wahrgenommen und aufgrund einer gleichzeitig bestehenden starken Unzufriedenheit im Dienstalltag wenig Kompensationsmöglichkeiten zur Verfügung gehabt. Eine langjährige Begleitung durch einen tiefenpsychologisch orientierten Psychotherapeuten tue ihm gut, habe jedoch sein Befinden nicht verbessern können, so dass er nach weiteren Unterstützungsmöglichkeiten suchte.

2. Psychopathologischer Befund

Der Beamte erschien pünktlich und sorgfältig gekleidet zum Beratungstermin beim ZPD. Er war höflich im Kontakt, wirkte dabei kontrolliert, berichtete jedoch offen von seiner Problematik. Weiterhin war er bewusstseinsklar und in allen Qualitäten orientiert, Aufmerksamkeit und Konzentration waren nicht gestört. Es waren keine Auffassungsstörungen sowie kein gestörtes Abstraktionsvermögen erkennbar und es bestanden weder Merkfähigkeits- noch Gedächtnisstörungen. Er zeigte keine formalen Denkstörungen und der Gedankengang war geordnet. Kein Wahn, keine Ich-Störungen, keine Phobien. Er machte seine Belastung deutlich, lieferte jedoch keine Hinweise auf akute Suizidalität.

3. Biographischer Hintergrund

Der Klient sei mit einem jüngeren Bruder (-5) aufgewachsen, welcher nach Internatsbeschulung „auf die schiefe Bahn" geraten sei und bis heute mit psychischen Problemen kämpfe. Die Trennung der Eltern habe sich beginnend mit seinem 15. Lebensjahr über einige Jahre gezogen und sei schließlich ein „Rosenkrieg" gewesen. Herr BRAND habe dabei die „Vermittlerrolle" innegehabt und sich mit dem damit einhergehenden Loyalitätskonflikt permanent überfordert gefühlt. Die Mutter sei im Oktober vergangenen Jahres nach einer kurzen belastenden Krankheitsphase verstorben, der Vater leide an Morbus Crohn und verweigere soziale Kontakte, was die Beziehung zu ihm herausfordernd gestalte.

4. Sozialanamnese

Herr BRAND sei langjährig verheiratet und habe drei Kinder im Alter von 13 bis 19 Jahren. Seine Kernfamilie gebe ihm Stabilität und Halt. Er habe zeitlebens Fußball gespielt und engagiere sich heute leidenschaftlich als Trainer für seinen jüngsten Sohn und dessen Mannschaft. Zudem übe er ein wenig Kraftsport aus und äußerte: „Ich kann alles, aber nichts richtig."

Zum Polizeidienst sei er spät gekommen, nachdem er zuerst einige Semester Maschinenbau studiert und in der Folge einen kaufmännischen Beruf erlernt und ausgeübt habe. Er habe unmittelbar das Gefühl gehabt, dort seine Fähigkeiten gut einsetzen zu können. Seine Bewerbung für die Verhandlungsgruppe im Jahr 2018 sei jedoch gescheitert, wodurch er im Anschluss ein Burnout entwickelt habe. Aktuell habe er eine Lehrtätigkeit im Bereich Verkehrssicherheit inne, verspüre jedoch aufgrund vieler struktureller Probleme große Unzufriedenheit.

5. Problemdarstellung und aktuelle Symptomatik

PHK BRAND erläuterte in der Beratung, dass er sich im Jahr 2015 aufgrund einer depressiven Symptomatik in psychotherapeutische Behandlung gegeben habe. Sein Frankfurter Therapeut arbeite tiefenpsychologisch mit ihm und habe bereits häufig Belastungsspitzen genommen. Eine Zeit lang sei dies durch die Einnahme des Antidepressivums Escitalopram unterstützt worden, aktuell nehme er keine Medikamente ein. Ein im Jahr 2018 diagnostiziertes Burnout habe zu einer stationären Maßnahme in einer psychosomatischen Klinik geführt. Aktuell verspüre er seit dem Tod seiner Mutter wieder eine zunehmende Stimmungsverschlechterung. Er sei morgens antriebslos und leide an Durchschlafschwierigkeiten. Er habe die Gedanken, dass mit dem Tod der Mutter auch die Möglichkeit dahin sei, noch bestimmte Dinge zu klären, beziehungsweise kämen in der Auseinandersetzung mit ihrem Verlust viele Erinnerungen hoch, die ihn überfordern würden. Aktuell fehle es ihm an Strategien, damit umzugehen, die Unzufriedenheit auf seiner Dienststelle koste ihn bereits länger viel Energie. Er erkenne an seinen Symptomen, dass er erneut in eine Depression rutsche. Sein Therapeut, den er in mehrwöchigen Abständen sehe, habe ihm zu einem therapeutischen Richtungswechsel und bestenfalls zu einer stationären Maßnahme mit anschließender ambulanter Weiterbehandlung geraten.

6. Bisherige Maßnahmen

Seit 2015 ambulante tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie und bis heute entlastende Gespräche, zwischendurch unterstützt durch Escitalopram.

2018 viermonatige stationäre Maßnahme in einer psychosomatischen Rehaklinik aufgrund eines Burnouts infolge einer massiven dienstlichen Enttäuschung.

7. Diagnose

Aufgrund der Schilderungen des Klienten besteht der dringende Verdacht auf eine rezidivierende depressive Episode, derzeit womöglich mittelgradig (ICD-10: F33.1). Im BDI-II erreichte er ebenfalls mit einem Wert von 27 eindeutig den Cut-off-Wert für den Hinweis auf das Vorliegen einer depressiven Symptomatik.

8. Empfehlungen

PHK BRAND zeigte sich im Rahmen seiner Beratung beim ZPD sehr motiviert für psychotherapeutische Interventionen. Aufgrund des sich abzeichnenden Rezidivs seiner depressiven Erkrankung mit zunehmenden Symptomen ist einer stationären Maßnahme im Sinne eines psychosomatischen Krankenhausaufenthaltes der Vorzug vor einer ambulanten Psychotherapie zu geben. In seinem Zustand gewährleistet die multimodale und multiprofessionelle Komplexbehandlung in einem stationären Setting am Ehesten und Schnellsten die Auflösung des Zustandes körperlicher und emotionaler Beeinträchtigung, welcher der Klient derzeit ausgesetzt ist. Durch Erleben einer Auszeit im sicheren Rahmen soll dem Klienten eine psychische Stabilisierung und Modifikation dysfunktionaler Gedanken und Verhaltensweisen ermöglicht werden, bevor ihm jegliche Handlungsinitiative verloren geht. Es sollen Bewältigungsstrategien erarbeitet werden, welche ihm dabei helfen, mit den aktuell belastenden Rahmenbedingungen im Polizeidienst funktionaler umzugehen sowie die durch den Tod der Mutter aufkommenden Kognitionen und Emotionen bearbeiten und integrieren zu können.

Ziel ist momentan die Behandlung der bereits gefährdeten Gesundheit, um das depressive Rezidiv abzufangen, bevor sich die Symptomatik weiterhin chronifiziert und um somit auch die Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Die Aufnahme einer ambulanten Psychotherapie im Anschluss ist höchstwahrscheinlich indiziert, um die im stationären Setting erarbeiteten Strategien in den Alltag überführen zu können.

B. Conrad

i.A. Conrad
(Dipl.-Psych'in, Psychologische Psychotherapeutin)

i.A. Willrich
(PsychD'in, Zentrum für polizeipsychologische Dienst und Services)